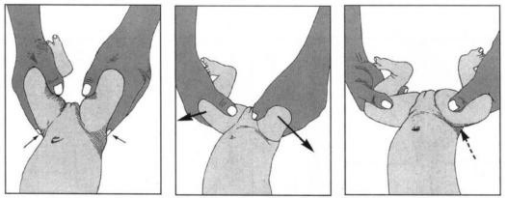
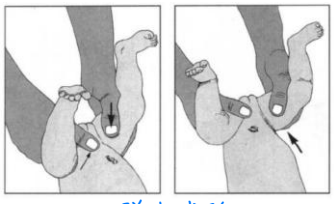
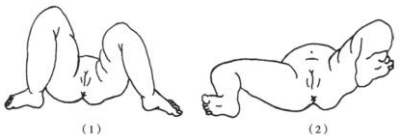
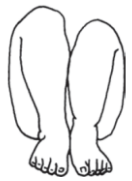
⑦治疗：

新生儿期（0-6 个月-黄金时期）	Pavlik 吊带维持髋关节屈曲外展（六味地黄丸、外面去拍拍）
婴儿期（6 个月-1.5 岁）	闭合复位固定于“人类位”
幼儿期（1.5 岁-3 岁）	切开复位
儿童期及以上（3 岁以上）	切开复位，Salter 骨盆截骨（1.5-6 岁、髋臼指数＜45°、以前缘缺损为主）

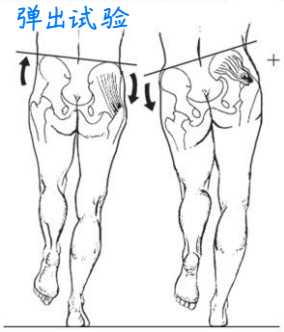

弹入试验

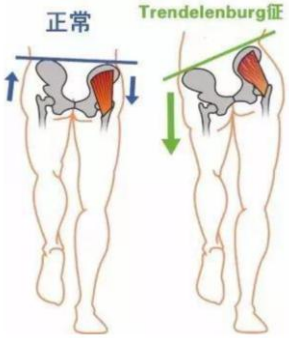

弹出试验


图 59-3　阳性体征及检查试验
（1）双下肢不等长，左大腿内侧皱褶增加，左臀部呈现凹陷状　（2）髋关节屈曲外展试验显示左侧阳性，右侧正常


图 59-4　Allis 征左侧膝关节低于健侧（右）




图 59-5　Trendelenburg 征（单足站立试验）



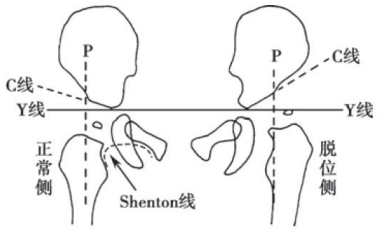


图 59-7　Perkin 象限、髋臼指数及 Shenton 线示意图



图 59-6　X 线平片示儿童发育性髋关节脱位（右侧）

站立行走期才有

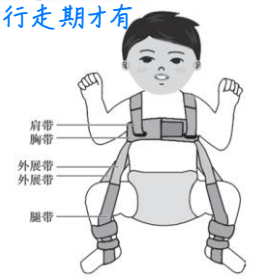




图 59-8　Pavlik 吊带治疗发育性髋关节脱位

三、特发性脊柱侧凸

①最常见的结构性脊柱侧凸

注意：非结构性脊柱侧凸是指脊柱及其支持组织无内在的固有改变，针对病因治疗后脊柱侧凸可消除。如神经根受刺激（腰椎间盘突出）、癔症、髋关节挛缩、姿势不当、下肢不等长、炎症（神医说知无不言）

②双肩不等高、胸廓不对称、剃刀背，可致慢性肺心病

③Cobb 角：＞10°诊断、＜20°观察随访、20-40°支具（恐怖四肢两对）、＞40°手术

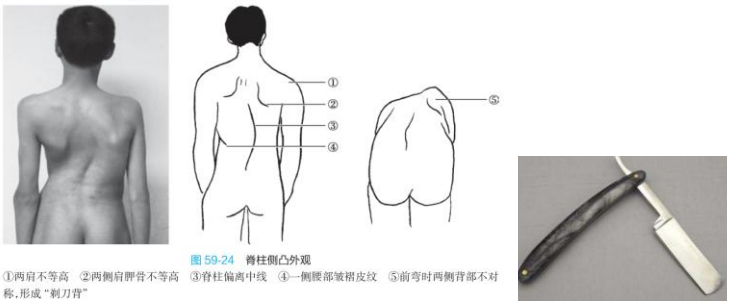


图 59-24　脊柱侧凸外观
①两肩不等高　②两侧肩胛骨不等高　③脊柱偏离中线　④一侧腰部皱褶皮纹　⑤前弯时两侧背部不对称，形成“剃刀背”

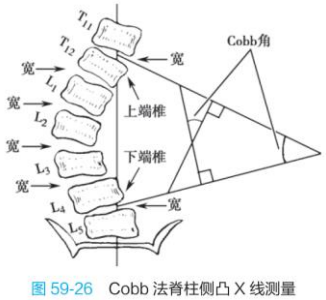


图 59-26　Cobb 法脊柱侧凸 X 线测量